

CAPÍTULO 13.7

Score de Tal

PERFIL EUNACOM 3.01.1.011

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

El **Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO)** es un cuadro clínico caracterizado por inflamación y estrechamiento de las vías respiratorias bajas, manifestándose principalmente con sibilancias, espiración prolongada y aumento del esfuerzo respiratorio. Es una de las causas más frecuentes de consulta en urgencias pediátricas en Chile.

Evaluación de la Severidad: Score de Tal

La decisión terapéutica en el SBO se basa estrictamente en la severidad del cuadro, la cual se mide mediante el **Score de Tal**. Este puntaje evalúa cuatro parámetros: frecuencia respiratoria (según edad), presencia de sibilancias, uso de musculatura accesoria (retracción) y cianosis.

TABLA 13.7.1: PUNTAJE VS FRECUENCIA RESPIRATORIA (< 6 MESES)

PUNTAJE	FRECUENCIA RESPIRATORIA (< 6 MESES)	FRECUENCIA RESPIRATORIA (> 6 MESES)	SIBILANCIAS	RETRACCIÓN (TIRAJE)
0	≤ 40	≤ 30	Ausentes	Ausente
1	41 - 55	31 - 45	Fin de espiración	Leve (intercostal)
2	56 - 70	46 - 60	Inspiratorias y espiratorias	Moderada (generalizada)
3	> 70	> 60	Audibles a distancia / Silencio	Grave (supraesternal/aletas)

NOTA CLÍNICA

Fisiopatología del SBO: El proceso obstructivo resulta de una combinación de tres factores: edema de la mucosa bronquial, hipersecreción de mucus y bronconstricción (contracción del músculo liso). En lactantes pequeños, el componente inflamatorio y de secreciones suele ser predominante sobre el broncoespasmo.

Manejo según Severidad

1. SBO Leve (Score de Tal 0 - 5)

El manejo es ambulatorio. Un puntaje de 0 no constituye diagnóstico de SBO, pero en el rango de 1 a 5 se procede de la siguiente manera: - **Tratamiento:** Se administran **2 puffs de Salbutamol** (100 mcg cada uno) mediante aerocámara. - **Disposición:** Alta para el hogar con indicaciones claras. - **Educación:** Se debe entregar una hoja de reconsulta con **signos de alarma:** - Fiebre alta o persistente (sospecha de sobreinfección bacteriana o **Neumonía Adquirida en la Comunidad**). - Aumento del esfuerzo respiratorio (hundimiento de costillas). - Dificultad para alimentarse o rechazo alimentario. - Compromiso del estado general.

2. SBO Moderado (Score de Tal 6 - 8)

Requiere manejo en el servicio de urgencia o sala de procedimientos (Sala IRA). - **Tratamiento inicial:** Se realiza un "set de rescate" que consiste en **2 puffs de Salbutamol cada 10 minutos por 1 hora** (total 6 veces). - **Reevaluación:** Al cabo de una hora se evalúa la respuesta. Si el paciente mejora, puede continuar manejo ambulatorio; si no mejora o empeora, se debe considerar el escalamiento terapéutico o la hospitalización. - **Vía de administración:** Se prefiere el uso de Inhalador de Dosis Medida (MDI) con **aerocámara** por sobre la nebulización, ya que es más costo-efectiva, fácil de usar y tiene menos efectos adversos.

3. SBO Severo (Score de Tal 9 - 12)

Es una emergencia médica que requiere estabilización inmediata. - **Prioridad:** Corregir la **hipoxemia**. - **Tratamiento:** Oxigenoterapia para mantener saturación ≥ 93%, broncodilatadores de rescate y evaluación inmediata para hospitalización.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Perla EUNACOM: La medida más importante en cualquier cuadro respiratorio agudo es la corrección de la hipoxemia. Si el paciente desatura (<93%), el oxígeno es la primera medida, independientemente del puntaje del Score de Tal.

Farmacoterapia Específica

Salbutamol e Ipratropio

El **Salbutamol** (beta-2 agonista) es el pilar del tratamiento. Sin embargo, en ciertos escenarios se prefiere o se añade **Bromuro de Ipratropio**. - **Indicaciones de Ipratropio:** - Pacientes con efectos adversos marcados por Salbutamol (taquicardia severa, temblor). - Pacientes cardiopatas. - Pacientes que ya han recibido dosis altas de Salbutamol en domicilio sin respuesta. - **Uso combinado:** Habitualmente se utiliza mezclado con dosis más bajas de Salbutamol para potenciar el efecto broncodilatador por dos vías distintas.

Corticoides

Los **corticoides** sistémicos (betametasona, prednisolona) no se usan de rutina en casos leves, pero son fundamentales en: - **SBO Recurrente:** Ayudan a disminuir la duración de la crisis y evitar recaídas. - **Falta de respuesta:** Si el paciente no mejora tras 1-2 horas de tratamiento con broncodilatadores. - **SBO Severo:** Todo paciente que se decide hospitalizar debe recibir corticoides.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Error común: No confundir el manejo de la crisis aguda con el tratamiento de mantención. El uso de corticoides inhalados (como Fluticasona) es para el control a largo plazo del **Asma Bronquial** o SBO recurrente, no para el rescate en el servicio de urgencia.

Criterios de Hospitalización

La decisión de hospitalizar se basa en la severidad clínica y la respuesta al tratamiento inicial:

- **Severidad extrema:** Score de Tal de 11 o 12 puntos al ingreso.
- **Fracaso al tratamiento en SBO Severo:** Score de 9-10 que persiste por más de 1 hora a pesar del manejo.
- **Fracaso al tratamiento en SBO Moderado:** Score de 6-8 que persiste por más de 2 horas sin mejoría significativa.
- **Factores sociales:** Incapacidad de los cuidadores para cumplir el tratamiento o lejanía del centro de salud.
- **Comorbilidades:** Prematurez extrema, cardiopatías congénitas o enfermedades neuromusculares.

Resumen de la Evidencia

Aunque las guías clínicas recomiendan ampliamente el uso de broncodilatadores y corticoides, es importante notar que: - El **oxígeno** es la intervención con mayor evidencia de beneficio en cuadros graves. - El uso de puffs con aerocámara es equivalente o superior a las nebulizaciones en la mayoría de los pacientes. - El manejo debe ser dinámico: si el paciente se agrava antes de completar la hora de observación, se debe reevaluar y actuar de inmediato.

NOTA CLÍNICA

Recuerda que el SBO en menores de 2 años puede ser la manifestación de una **Bronquiolitis Aguda**, donde la respuesta a broncodilatadores es variable y el pilar es el soporte (aseo nasal, hidratación y oxígeno).

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Lactante de 9 meses consulta por dificultad respiratoria. Al examen: frecuencia respiratoria 50/min, retracción intercostal, sibilancias espiratorias e inspiratorias, sin cianosis. ¿Cuál es el puntaje del score de Tal y su clasificación de severidad?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Score de Tal. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Score de Tal: leve 0-5, moderado 6-8, severo 9-12 puntos (máximo 12)
- Evalúa 4 variables: frecuencia respiratoria, musculatura accesoria, cianosis y sibilancias
- Frecuencia respiratoria: puntos de corte 30, 45, 60 (suben de 15 en 15); en <6 meses se suma 10
- Musculatura accesoria en SBO progresa de abajo hacia arriba: subcostal (1), intercostal (2), cervical (3)
- En laringitis obstructiva la progresión es inversa: de arriba hacia abajo
- Cianosis: perioral con llanto (1), perioral constante (2), generalizada (3)
- Sibilancias: espiratorias (1), inspiratorias + espiratorias (2), audibles sin fonendoscopio o silencio pulmonar (3)
- El silencio pulmonar en un paciente con signos de gravedad indica SBO muy severo (3 puntos)

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (SCORE DE TAL)**PREGUNTA 1**

Lactante de 9 meses consulta por dificultad respiratoria. Al examen: frecuencia respiratoria 50/min, retracción intercostal, sibilancias espiratorias e inspiratorias, sin cianosis. ¿Cuál es el puntaje del score de Tal y su clasificación de severidad?

- A)** 4 puntos, SBO leve
- B)** 8 puntos, SBO moderado
- C)** 6 puntos, SBO moderado
- D)** 7 puntos, SBO moderado
- E)** 6 puntos, SBO leve

PREGUNTA 2

Lactante de 4 meses con SBO presenta frecuencia respiratoria de 58/min. Según el score de Tal, ¿cuántos puntos corresponden a este parámetro?

- A)** 1 punto
- B)** 2 puntos
- C)** 3 puntos
- D)** 0 puntos
- E)** No se puede calcular sin conocer las otras variables

PREGUNTA 3

Lactante de 11 meses con cuadro respiratorio agudo. Al examen: cianótico, muy taquipneico, con retracción cervical marcada y al auscultar no se escuchan sibilancias ni murmullo pulmonar. ¿Cuál es la interpretación correcta de la ausencia de sibilancias?

- A)** El paciente no tiene obstrucción bronquial, corresponde a 0 puntos en sibilancias
- B)** Indica silencio pulmonar por obstrucción severa, corresponde a 3 puntos
- C)** Sugiere que el diagnóstico no es un SBO sino otra patología
- D)** Corresponde a 1 punto porque no hay sibilancias audibles
- E)** Se debe esperar a que mejore con broncodilatador para reevaluar

RESUMEN: SCORE DE TAL

El score de Tal es la herramienta clínica utilizada para evaluar la severidad del síndrome bronquial obstructivo (SBO). Se clasifica como leve (0-5 puntos), moderado (6-8 puntos) y severo (9-12 puntos, siendo 12 el máximo). Evalúa cuatro variables clínicas: frecuencia respiratoria, uso de musculatura accesorio, cianosis y sibilancias, cada una puntuada de 0 a 3 según intensidad. La frecuencia respiratoria se puntúa según los siguientes cortes: menor a 30/min = 0 puntos, 30-44/min = 1 punto, 45-59/min = 2 puntos, y 60 o más/min = 3 puntos. El patrón es que empieza en 30 y sube de 15 en 15. En menores de 6 meses, se suman 10 a cada punto de corte (40, 55 y 70 respectivamente). El uso de musculatura accesorio progresa de abajo hacia arriba: 0 puntos sin uso, 1 punto subcostal, 2 puntos intercostal y 3 puntos tiraje cervical. Esto es opuesto a la laringitis obstructiva donde la progresión es de arriba hacia abajo. La cianosis se clasifica como: 0 puntos sin cianosis, 1 punto perioral con el llanto, 2 puntos perioral constante y 3 puntos cianosis generalizada. Las sibilancias se clasifican como: 0 puntos sin sibilancias, 1 punto espiratorias solamente, 2 puntos inspiratorias y espiratorias, y 3 puntos audibles sin fonendoscopio o silencio pulmonar. Es importante distinguir el silencio pulmonar: si el paciente está bien y sin sibilancias, el puntaje es 0; pero si está cianótico, taquipneico y con uso de musculatura accesorio sin auscultar sibilancias, el silencio pulmonar indica gravedad extrema (3 puntos) y sugiere un SBO muy severo.